

# 新・家庭医療専門医制度の改訂

ポートフォリオ 2 割削減とかかりつけ医機能報告制度

これは「楽になった」のか？ それとも「質がもっと問われる」のか？

## 今日の学習目標（15 分）

- 説明できる — 制度変更の具体的内容と背景（理解）
- 比較できる — 旧制度と新制度の差分を分析（分析）
- 立案できる — ポートフォリオ戦略を描ける（創造）

# 20 → 16

ポートフォリオ領域 2 割削減

学会発表 3 件→2 件

# Quick Poll — 今の知識を確認しよう

事象 3: 前提条件の想起 | 2-4 分

☒ 新・家庭医療専門医制度のポートフォリオを書いたことがある人？

☒ 「かかりつけ医機能報告制度」という言葉を聞いたことがある人？

☒ 第 17 回 JPCA 学術大会（2026 年 5 月・京都）に参加予定の人？

今、専門医制度と医療政策が同時に大きく動いています。研修医・専攻医にとって「制度を知る」ことは、キャリア戦略そのものです。

# ポートフォリオ領域の前後比較

事象 4: 新しい内容の提示 | 4-7 分

## 削減された 4 領域（旧 17-20）→ 統合先

| 旧 # | 削減された領域     | 統合先                     |
|-----|-------------|-------------------------|
| 17a | 複雑困難事例のケア   | → 多疾患併存 (4) ・ 慢性疾患 (3)  |
| 17b | 統合されたケア     | → チーム医療 (12) ・ 地域志向 (8) |
| 18a | プロフェッショナリズム | → 医療者自身のケア (16)         |
| 18b | 倫理的困難な意思決定  | → 患者中心の医療 (6)           |
| 19a | セクシャルヘルス    | → 各関連領域                 |
| 19b | 思春期のケア      | → 各関連領域                 |
| 20a | 緩和ケア        | → 長期的な全人的関係 (5)         |
| 20b | 人生の最終段階のケア  | → 長期的な全人的関係 (5)         |

## コア 16 領域は変更なし

- 1. 未分化な健康問題
- 2. 予防医学と健康増進
- 3. 慢性疾患のケア
- 4. 多疾患併存
- 5. 長期的な全人的関係
- 6. 患者中心の医療
- 7. 家族志向のケア
- 8. 地域志向の PC
- 9. 障害とりハビリ
- 10. 臨床における教育
- 11. EBM の実践
- 12. チーム医療
- 13. システム思考
- 14. メンタルヘルス
- 15. 社会的決定要因
- 16. 医療者自身のケア

領域が「消えた」のではなく、既存領域に統合された。  
1 つのポートフォリオに求められる多面性と深さがむしろ増している。

# その他の変更 + かかりつけ医機能報告制度

事象 4+5 | 7-9 分

| 項目         | 旧制度   | 新制度            |
|------------|-------|----------------|
| ポートフォリオ領域数 | 20 領域 | 16 領域          |
| 学会発表必要件数   | 3 件以上 | 2 件以上          |
| 適用開始       | —     | 2025 年 3 月修了者～ |

## かかりつけ医機能報告制度

| 項目   | 内容                     |
|------|------------------------|
| 根拠法  | 2023 年医療法改正            |
| 施行   | 2025 年 4 月             |
| 初回報告 | 2026 年 1 月～ 3 月（G-MIS） |
| 報告内容 | 17 診療領域・40 疾患対応力 等     |
| 目的   | 患者が医療機関を選べるように         |

家庭医療専門医の研修で培う能力 ⇨ かかりつけ医機能報告で求められる能力  
あなたの存在が、医療機関の「かかりつけ医機能」を高める

- 報告制度の 17 診療領域 ⇨ 家庭医が日常的に扱う領域
- 「総合診療専門医を配置しているか」が報告項目に含まれる
- あなたの存在が医療機関の「かかりつけ医機能」を高める

# ペアディスカッション — 自分の戦略を考える

事象 6+7: 練習 + フィードバック | 9-13 分 | ペアワーク 3 分 + 共有 1 分

## 問い A (専攻医向け)

ポートフォリオが 16 領域になった今、残りの研修期間でどの領域を「質の高い事例」として書きたいか？ その理由は？

## 問い B (研修医向け)

かかりつけ医機能報告制度で求められる能力のうち、今の研修で意識的に伸ばせるものは何か？

## 問い C (指導医向け)

ポートフォリオの領域が統合された今、指導でどんな点を強調するか？

隣の人とペアを組み、3 つの問いから 1 つ選んで話し合ってください

# 振り返りと持ち帰り

事象 8+9 | 13-15 分

## 1. 量から質へ

20→16 領域の削減は、1 事例あたりの深さ・多面性を重視する方向

## 2. 制度と教育の融合

かかりつけ医機能報告制度と専門医研修は同じ方向を向いている

## 3. あなたの価値

総合診療 / 家庭医療専門医は、これからの医療制度で求められる存在

## 持ち帰りの問い

「自分のポートフォリオで一番自信のある領域と、一番苦手な領域は何か？  
苦手な領域を、どの臨床場面で経験できるか？」

## 次のアクション

- JPCA 公式サイトで新 16 領域の詳細を確認
- 第 17 回 JPCA 学術大会（5/29-31 京都）の演題募集チェック
- 指導医とポートフォリオ進捗を振り返る機会を設定